



РОССИЙСКИЙ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.П. ПАВЛОВА

ISSN 0204-3475 (Print) ISSN 2500-2546 (Online)

☰ Меню Архив

[Главная](#) > [Архив](#) > [Том 34, № 1 \(2026\)](#) > **[Сравнительный анализ динамики лабораторных показателей и исходов острого панкреатита у пациентов с сопутствующим поражением печени](#)**

Сравнительный анализ динамики лабораторных показателей и исходов острого панкреатита у пациентов с сопутствующим поражением печени



■ **Авторы:** [Чавга А.И.](#)¹, [Мидленко О.В.](#)¹, [Мидленко В.И.](#)¹, [Шамсутдинов С.М.](#)¹

■ **Учреждения:**

1. Ульяновский государственный университет

■ **Выпуск:** Том 34, № 1 (2026)

■ **Страницы:** 25-32

■ **Раздел:** [Оригинальные исследования](#)

■ **Статья получена:** 18.04.2024

■ **Статья одобрена:** 05.11.2024

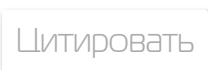
■ **Статья опубликована:** 31.03.2026

■ **URL:** <https://journals.eco-vector.com/pavlovj/article/view/630488>

■ **DOI:** <https://doi.org/10.17816/PAVLOVJ630488>

■ **EDN:** <https://elibrary.ru/YVDNLB>

■ **ID:** 630488



Полный текст



Открытый доступ



Доступ предоставлен



Доступ платный или только для подписчиков



(RUSSIAN)

Аннотация

Обоснование. Оценка функции и степени поражения печени может обладать большой диагностической значимостью в прогнозировании исходов острого панкреатита (ОП).

Цель. Оценить влияние сопутствующего поражения печени на динамику лабораторных показателей и исходы у пациентов с острым панкреатитом.

Методы. В ретроспективное когортное одноцентровое исследование включено 94 пациента хирургического стационара, госпитализированных по поводу ОП. Пациенты были разделены на 2 группы: основная группа — со значимым поражением печени ($n = 48$; средний возраст $51,7 \pm 15,7$ лет; 57,0% мужчин и 43,0% женщин) и группа контроля — без такового ($n = 46$; средний возраст $52,6 \pm 16,2$ года; 54,3% мужчин и 45,7% женщин).

Результаты. На третьи и пятые сутки в основной группе зарегистрированы более высокие значения активности трансаминаз по сравнению с группой контроля (более выраженный синдром цитолиза). По уровню билирубина на третьи сутки обе группы с клинической точки зрения были сопоставимы ($43,13 \pm 6,93$ мкмоль/л и $42,13 \pm 6,55$ мкмоль/л), несмотря на статистическую значимость различий ($p < 0,001$). К пятым суткам уровень билирубина в группе контроля существенно снизился ($22,37 \pm 3,82$ мкмоль/л), а в основной группе оставался на более высоком уровне ($30,27 \pm 9,39$ мкмоль/л, $p < 0,001$). Уровни общего белка сыворотки, общего холестерина сыворотки, триглицеридов сыворотки в изучаемых временных точках различий не продемонстрировали (для всех сравнений $p > 0,05$). Фибриноген плазмы у пациентов с ОП в первые сутки госпитализации не продемонстрировал различий между группами, при этом средние значения находились в пределах референсных (200–400 мг/дл), на третьи сутки наблюдался рост в обеих группах с превышением среднего значения верхней границы референсных значений и тенденцией к формированию различия между группами. Однако на пятые сутки в основной группе отмечено значительное повышение уровня фибриногена — до $647,86 \pm 143,09$ мг/дл, в группе контроля — $455,48 \pm 147,00$ мг/дл ($p = 0,001$). У 14 (29,16%) пациентов основной группы среднетяжелое течение ОП перешло в тяжелую, в группе контроля — у 5 (10,87%) пациентов. Кроме того, зарегистрировано по одному случаю летального исхода в группах.

Заключение. У части пациентов с ОП течение основного заболевания осложняется синдромами гепатоцитолита и холестаза. У таких пациентов среднетяжелое течение ОП чаще переходит в тяжелое. В ходе исследования была подтверждена гипотеза о том, что оценка функции и степени поражения печени может обладать большой диагностической значимостью в прогнозировании исходов острого панкреатита, быть предметом для изучения эффективности различных тактик лечения панкреатита.

Ключевые слова

острый панкреатит, АСТ, АЛТ, билирубин, поражения печени, синдром цитолиза, билирубинемический синдром

Полный текст



Об авторах

Андрей Иванович Чавга

Ульяновский государственный университет

Автор, ответственный за переписку.

Email: andrei.chavga@yandex.ru

ORCID iD: [0000-0001-7628-5039](https://orcid.org/0000-0001-7628-5039)

SPIN-код: [1839-1310](https://www.spin-код.ru/1839-1310)

канд. мед. наук

Россия, Ульяновск

Олег Владимирович Мидленко

Ульяновский государственный университет

Email: 953151@mail.ru

ORCID iD: [0000-0001-8076-7145](https://orcid.org/0000-0001-8076-7145)

SPIN-код: [5381-9674](https://www.spin-portal.ru/5381-9674)

д-р мед. наук, профессор

Россия, Ульяновск

Владимир Ильич Мидленко

Ульяновский государственный университет

Email: imefc@ulsu.ru

ORCID iD: [0000-0003-4358-8484](https://orcid.org/0000-0003-4358-8484)

SPIN-код: [1558-4467](https://www.spin-portal.ru/1558-4467)

д-р мед. наук, профессор

Россия, Ульяновск

Сайдаш Миргасимович Шамсутдинов

Ульяновский государственный университет

Email: saydash50@rambler.ru

ORCID iD: [0009-0000-2103-1867](https://orcid.org/0009-0000-2103-1867)

Россия, Ульяновск

Список литературы

1. Ershov AV, Dolgikh VT. Influence factors on pancreatogenic contractility and metabolism of isolated rat heart. *Sibirskiy Meditsinskiy Zhurnal (Irkutsk)*. 2015;(6):62–68. EDN: VSTNUD
2. Shcherbyuk AN, Morozov SV, Lobakov AI, et al. Comparative evaluation of scales to determine severity of acute pancreatitis. *Bulletin of the Medical Institute "REAVIZ" (Rehabilitation, Doctor and Health)*. 2023;13(2):49–55. doi: [10.20340/vmi-rvz.2023.2.CLIN.9](https://doi.org/10.20340/vmi-rvz.2023.2.CLIN.9). EDN: GWPVGR
3. Ektov VN, Khodorkovskiy MA, Fedorov AV. Radiation methods of visualization in diagnostics and assessment of the severity of acute pancreatitis (review of literature). *Experimental and Clinical Gastroenterology*. 2021;(11):42–45. doi: [10.31146/1682-8658-ecg-195-11-42-51](https://doi.org/10.31146/1682-8658-ecg-195-11-42-51). EDN: YHTFSO
4. Groyzik KL, Kostyrnoy AV, Alekseeva YeS, et al. New options in the management of acute pancreatitis. *Tavrisheskiy Mediko-Biologicheskiy Vestnik*. 2022;25(2):38–43. EDN: IUUIOP
5. Bulava GV. Immunopathogenesis of Acute Pancreatitis. *Russian Sklifosovsky Journal "Emergency Medical Care"*. 2022;11(3):484–492. doi: [10.23934/2223-9022-2022-11-3-484-492](https://doi.org/10.23934/2223-9022-2022-11-3-484-492). EDN: DPMHOI
6. Nikitsina EV, Ilukevich GV. Multiple organ dysfunction syndrome in acute necrotizing pancreatitis. *Novosti Khirurgii*. 2021;29(5):598–606. doi: [10.18484/2305-0047.2021.5.598](https://doi.org/10.18484/2305-0047.2021.5.598). EDN: UNIIJR
7. Nikitsina EV, Ilukevich GV. Clinical and laboratory assessment of systemic inflammatory response syndrome in patients with acute severe pancreatitis. *Vestnik VGMU*. 2023;22(3):55–62. doi: [10.22263/2312-4156.2023.3.55](https://doi.org/10.22263/2312-4156.2023.3.55). EDN: TLZBOI
8. Makarova MA, Baranova IA. Main hepatic syndromes in practice of internist. *Consilium Medicum*. 2017;19(8):69–74. EDN: ZRSTKZ
9. Belov DV, Lukin OP, Fokin AA, et al. Abdominal complications after cardiopulmonary bypass surgery: data analysis for 2011–2021. *Clinical and Experimental Surgery. Petrovsky Journal*. 2022;10(2):96–102. doi: [10.33029/2308-1198-2022-10-1-96-102](https://doi.org/10.33029/2308-1198-2022-10-1-96-102). EDN: PJGPGU

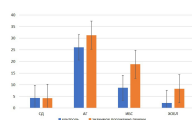
Дополнительные файлы

Доп. файлы

1. JATS XML

[Скачать](#)

2. Рис. 1. Частота (%) сопутствующих хронических заболеваний у пациентов с острым панкреатитом и значимым поражением печени и пациентов с острым панкреатитом без доказательств значимого поражения печени: СД — сахарный диабет; АГ — артериальная гипертензия; ИБС — ишемическая болезнь сердца; ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь легких.



[Скачать \(112KB\)](#) [Метаданные](#)

Статистика

Просмотры

Аннотация: 112

PDF (Русский): 2

PDF (Английский): 1

Метрики статей

Просмотры PDF: 3



PlumX



Нет доступных показателей.

 **PLUMX** - [см. подробнее](#)

© Эко-Вектор, 2026

Ссылка на описание лицензии: https://eco-vector.com/for_authors.php#07



СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации СМИ: серия ПИ № [ФС77-76803](#) от 24 сентября 2019 года.

Developed by ECO-VECTOR

Powered by EVESYST

